Estilo UERJ

Simulado 7 Caderno

Prova inédita no formato da UERJ: quatro alternativas, casos longos e a armadilha da banca em cada questão.

50 questões

17 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 50 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 2 horas e 30 minutos, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Mulher de 48 anos, com leucemia mieloide aguda, está no 18º dia de quimioterapia de indução, com neutrófilos de 60/mm³ há 15 dias, e em profilaxia com voriconazol desde o início do ciclo. Há 2 dias tem febre persistente apesar de meropeném e vancomicina, dor e edema na hemiface esquerda e obstrução nasal. Nasofibroscopia: área de mucosa enegrecida no corneto médio esquerdo. Exame: edema palpebral à esquerda, sem alteração visual. Glicemia 128 mg/dL. Galactomanana sérica: índice 0,2 em duas amostras. TC de seios da face: opacificação etmoidomaxilar com erosão óssea. TC de tórax: nódulo de 2 cm com sinal do halo invertido. O agente mais provável é:

A) Mucorales (Rhizopus)

B) Aspergillus fumigatus

C) Candida krusei

D) Pseudomonas aeruginosa

---

2 Mulher de 29 anos tem linfonodos cervicais e supraclaviculares esquerdos há 3 meses e prurido generalizado intenso, pior à noite. Perdeu 4 kg em 4 meses (peso habitual de 66 kg). Nega febre e sudorese noturna. A biópsia mostrou linfoma de Hodgkin, subtipo esclerose nodular. PET-CT: linfonodos cervicais e supraclaviculares esquerdos, massa mediastinal anterior de 6 cm (menor que um terço do diâmetro torácico), linfonodos do hilo esplênico e múltiplos focos hipermetabólicos no baço; fígado, pulmões, ossos e medula óssea sem captação anormal. O estádio de Ann Arbor, com a modificação de Lugano, é:

A) IIA

B) IIIB

C) IIIA

D) IVA

---

3 Homem de 41 anos, ex-tabagista de 12 maços-ano (parou há 5 anos), tem dispneia progressiva há 2 anos. Trabalhou 6 anos com polimento de pisos de granito. Espirometria: VEF1/CVF 0,52, VEF1 48% do previsto, sem resposta ao broncodilatador; DLCO 45%. TC de tórax: enfisema panlobular de predomínio nos lobos inferiores, sem nódulos, bronquiectasias ou cistos. Trouxe exames de check-up: hemograma normal, ALT 58 U/L, AST 49 U/L, eletroforese de proteínas séricas com albumina 4,2 g/dL, fração alfa-1 de 0,1 g/dL (referência 0,2 a 0,4) e gamaglobulina normal. Usa tiotrópio-olodaterol. A explicação mais provável para o quadro é:

A) Silicose com enfisema associado

B) Deficiência de alfa-1 antitripsina

C) DPOC tabágica de início precoce

D) Bronquiolite constritiva

---

4 Mulher de 78 anos, com depressão em uso de citalopram 40 mg/dia e hipertensão em uso de hidroclorotiazida, está internada há 3 dias por pneumonia comunitária, recebendo ceftriaxona com o antibiótico de dose diária única associado para cobertura de atípicos, além de um antiemético antagonista 5-HT3 por náuseas. Hoje teve dois episódios de pré-síncope. Monitor: salvas autolimitadas de taquicardia ventricular polimórfica, com QRS de amplitude que gira em torno da linha de base, precedidas de pausa. Entre as salvas, ritmo sinusal, FC 58 bpm e QTc de 590 ms. Consciente, PA 112×68 mmHg. Potássio 3,9 mEq/L e magnésio 2,0 mg/dL (VR 1,7 a 2,4). Além de suspender os fármacos que prolongam o QT, a conduta imediata é:

A) Cardioversão elétrica sincronizada

B) Amiodarona intravenosa

C) Procainamida intravenosa

D) Sulfato de magnésio intravenoso

---

5 Homem de 58 anos, com cirrose por hepatite C tratada (Child-Pugh B, MELD 15), tabagista de 30 anos-maço, refere dispneia progressiva aos esforços há 8 meses, que piora ao se levantar e melhora deitado. Exame: aranhas vasculares no tronco, baqueteamento digital, SpO2 de 93% deitado e 86% em pé, ausculta pulmonar normal, B2 normofonética. Gasometria em ar ambiente, sentado: PaO2 58 mmHg, PaCO2 32 mmHg, gradiente alvéolo-arterial de 48 mmHg. Radiografia de tórax e TC de tórax sem alterações parenquimatosas; espirometria com VEF1/CVF de 0,78 e CVF de 92% do previsto. Ecocardiograma transtorácico com microbolhas: microbolhas no átrio esquerdo após o quarto ciclo cardíaco, PSAP estimada em 28 mmHg, ventrículo direito normal. O diagnóstico mais provável é:

A) Hipertensão portopulmonar

B) Doença pulmonar obstrutiva crônica

C) Forame oval patente com shunt

D) Síndrome hepatopulmonar

---

6 Homem de 52 anos procura o pronto-socorro com visão dupla e 'pálpebras pesadas' há 24 horas; hoje tem dificuldade para engolir e fala anasalada, e há 6 horas notou fraqueza para elevar os braços. Há 10 dias teve diarreia que durou 3 dias. Refere boca muito seca e intestino preso desde ontem. Lúcido, afebril, PA 118/76 mmHg, FC 92 bpm. Ptose bilateral, oftalmoparesia em todas as direções, pupilas de 6 mm com reação lenta à luz, paresia facial bilateral; força grau 4 nos membros superiores proximais e grau 5 nos inferiores; reflexos profundos presentes e simétricos; sensibilidade normal; sem ataxia. CVF 2,6 L. Líquor: 1 célula/mm³, proteína 36 mg/dL. O diagnóstico mais provável é:

A) Síndrome de Guillain-Barré

B) Botulismo

C) Síndrome de Miller Fisher

D) Miastenia gravis

---

7 Homem de 45 anos, previamente hígido, iniciou amoxicilina-clavulanato para sinusite há 9 dias. Há 3 dias surgiram pápulas purpúricas que não desaparecem à digitopressão, simétricas, em pernas e tornozelos, algumas com centro vesiculoso, e artralgia leve de tornozelos. Sem dor abdominal, hemoptise, febre ou sintomas neurológicos. PA 122 × 78 mmHg. Plaquetas 260.000/mm³, creatinina 0,9 mg/dL. Biópsia de pele feita ontem: vasculite leucocitoclástica de vasos da derme superficial com depósitos de IgA na imunofluorescência. O antibiótico foi suspenso. O exame mais adequado neste momento é:

A) Biópsia renal percutânea

B) ANCA, crioglobulinas e complemento

C) Urina tipo 1 com sedimento

D) TC de abdome com contraste

---

8 Homem de 47 anos, com diabetes tipo 2 há 3 anos em uso de metformina (HbA1c 7,4%), hipertensão controlada com losartana e consumo de cerca de 6 latas de cerveja nos fins de semana, vem para revisão. Pai teve infarto aos 60 anos. Assintomático, sem dor abdominal. Exame: IMC 30 kg/m², pápulas amareladas com halo eritematoso nas nádegas e cotovelos, sem hepatomegalia. Exames: soro lactescente, triglicerídeos 1.460 mg/dL, colesterol total 392 mg/dL, HDL 28 mg/dL, LDL não calculado pelo laboratório, lipase normal, TSH normal, creatinina 0,9 mg/dL. Além de suspender o álcool, a conduta inicial mais adequada é:

A) Fenofibrato e dieta muito pobre em gordura

B) Ômega-3 em dose alta, isolado

C) Ezetimiba associada a estatina

D) Rosuvastatina 20 mg e dieta hipocalórica

---

9 Homem de 68 anos, hipertenso em uso de hidroclorotiazida 25 mg/dia há 3 anos, é avaliado por dor lombar há 2 meses e cansaço. Lúcido, orientado, sem edema, sem sinais de desidratação, PA 136/82 mmHg. Exames: sódio 130 mEq/L, potássio 4,0 mEq/L, glicose 96 mg/dL, ureia 48 mg/dL, creatinina 1,3 mg/dL, cálcio 10,1 mg/dL, proteínas totais 14,6 g/dL com albumina de 2,9 g/dL, triglicerídeos 160 mg/dL, hemoglobina 10,2 g/dL. O exame mais adequado a seguir, para conduzir a hiponatremia, é:

A) TC de crânio sem contraste

B) TSH e cortisol matinal

C) Osmolalidade sérica medida

D) Osmolalidade e sódio urinários

---

10 Homem de 64 anos, diabético, internado há 12 dias por pancreatite aguda, teve febre no 9º dia; hemoculturas periféricas e do cateter venoso central em jugular interna direita cresceram Staphylococcus aureus sensível à oxacilina. O cateter foi retirado no mesmo dia e iniciada oxacilina em dose plena. Hoje, após 72 horas de tratamento, mantém febre de 38,5 °C, e as hemoculturas de controle colhidas ontem estão positivas para o mesmo agente. Refere dor cervical à direita ao girar a cabeça. Exame: discreto empastamento e dor à palpação ao longo do esternocleidomastóideo direito, sem secreção no antigo orifício do cateter; sem sopros; sem dor à percussão da coluna; articulações livres. Ecocardiogramas transtorácico e transesofágico sem vegetações. O próximo exame mais adequado é:

A) PET-CT com FDG de corpo inteiro

B) Ultrassonografia Doppler venosa cervical

C) RM de coluna total

D) Repetir o ecocardiograma transesofágico

---

11 Mulher de 61 anos, no 5º dia de pós-operatório de artroplastia total de joelho, em enoxaparina profilática, fez endoscopia digestiva alta por dispepsia, com anestesia tópica da orofaringe por spray de benzocaína aplicado várias vezes por dificuldade com o exame. Quarenta minutos depois, apresenta dispneia leve, cefaleia e cianose de lábios e extremidades. PA 132 × 78 mmHg, FC 104 bpm, FR 22 irpm, ausculta pulmonar normal, panturrilhas sem edema. O oxímetro de pulso marca 85% e não sobe com máscara com reservatório a 15 L/min. Gasometria arterial colhida com a máscara: pH 7,44, PaO2 412 mmHg, PaCO2 34 mmHg, saturação calculada pelo aparelho de 99%. Radiografia de tórax normal. D-dímero 2.900 ng/mL. O próximo exame mais adequado é:

A) Cintilografia de ventilação e perfusão

B) Ecocardiograma com microbolhas

C) Cooximetria em sangue arterial

D) Angiotomografia de tórax

---

12 Mulher de 67 anos, com câncer de pulmão e metástases ósseas, usa metadona 10 mg de 8 em 8 horas há 3 semanas, sem mudança de dose, com boa analgesia e sem sonolência desde a primeira semana. Há 4 dias iniciou fluconazol 200 mg/dia por candidíase orofaríngea. Hoje a família relata sonolência excessiva desde ontem. Exame: Glasgow 12, pupilas mióticas, FR 9 irpm, SpO2 90% em ar ambiente, PA 122 × 70 mmHg. Exames: creatinina 0,8 mg/dL (igual à do mês passado), cálcio corrigido 9,6 mg/dL, sódio 138 mEq/L, glicemia 104 mg/dL. TC de crânio sem lesões novas. O mecanismo mais provável do quadro é:

A) Inibição do metabolismo hepático da metadona

B) Acúmulo de morfina-6-glicuronídeo por lesão renal

C) Acúmulo tardio pela meia-vida longa da metadona

D) Hipercalcemia da malignidade

---

13 Mulher de 31 anos, no 18º dia após cesariana de gestação gemelar complicada por pré-eclâmpsia, procura o pronto-socorro por dispneia progressiva há 5 dias, hoje aos mínimos esforços, com ortopneia e tosse seca. Está amamentando. Exame: PA 108×72 mmHg, FC 118 bpm, FR 26 irpm, SpO2 91% em ar ambiente, turgência jugular a 45 graus, B3 audível no ápice, crepitações em bases, edema simétrico de membros inferiores 2+/4+ e panturrilhas livres. ECG: taquicardia sinusal com alterações difusas e inespecíficas da repolarização. Radiografia: área cardíaca aumentada e redistribuição vascular. D-dímero 2.900 ng/mL (referência até 500), NT-proBNP 4.800 pg/mL e troponina discretamente elevada. O próximo exame é:

A) Ressonância magnética cardíaca

B) Cineangiocoronariografia

C) Angiotomografia de artérias pulmonares

D) Ecocardiograma transtorácico

---

14 Mulher de 58 anos, que nunca fumou, fez TC de tórax por tosse após um quadro viral, já resolvido. O exame mostra um nódulo único em vidro fosco puro de 8 mm no lobo superior direito, sem componente sólido, e nenhum outro achado. Não tem história de câncer e o exame físico é normal. Está muito ansiosa e pede para retirar o nódulo logo. Uma TC de abdome feita há 3 meses em outro hospital, por cólica renal, incluiu as bases pulmonares, mas não os ápices. A conduta mais adequada em relação ao nódulo é:

A) Biópsia percutânea guiada por TC

B) PET-CT com FDG

C) TC de tórax em 6 a 12 meses

D) Segmentectomia por videotoracoscopia

---

15 Homem de 38 anos, criado na zona rural de Minas Gerais, procura o ambulatório após três crises em 6 meses, que começam com abalos no braço esquerdo e às vezes evoluem para tônico-clônicas bilaterais. Nega febre, cefaleia ou déficit entre as crises; exame neurológico normal. TC de crânio: quatro calcificações puntiformes de 3 a 5 mm (frontal direita, parietal e occipitais). RM de encéfalo: lesões calcificadas, sem cisto viável, sem realce e sem edema perilesional. Imunoblot (EITB) sérico para cisticercose positivo. Fundo de olho normal. A conduta mais adequada é:

A) Carbamazepina, sem antiparasitário

B) Albendazol isolado por 14 dias

C) Albendazol, dexametasona e carbamazepina

D) Albendazol, praziquantel e dexametasona

---

16 Mulher de 58 anos procura o ambulatório por lesões cutâneas há 3 semanas, que pioram com o sol. Há 7 semanas iniciou tratamento oral para onicomicose dos pés, prescrito pelo dermatologista e ainda em curso. Hipertensa, usa losartana há 5 anos. Nega artralgia, úlceras orais, fenômeno de Raynaud, febre e edema. Exame: placas anulares eritematosas, de bordas descamativas e centro claro, no decote, na face extensora dos braços e na região cervical posterior, sem atrofia e sem cicatriz; face e couro cabeludo poupados. Hemograma, creatinina e EAS normais. FAN 1:640 padrão nuclear pontilhado fino, anti-Ro/SSA positivo, anti-histona negativo, anti-DNA nativo negativo, C3 e C4 normais. O diagnóstico mais provável é:

A) Lúpus discoide crônico

B) Lúpus sistêmico com anti-Ro

C) Tinha do corpo disseminada

D) Lúpus cutâneo subagudo induzido

---

17 Homem de 36 anos, com aids (CD4 24 células/mm³, carga viral 480.000 cópias/mL), abandonou a TARV há 1 ano e retomou tenofovir, lamivudina e dolutegravir há 10 dias. Há 3 semanas tem 6 a 8 evacuações por dia, com sangue e muco, dor em fossa ilíaca esquerda, tenesmo e febre de 38,3 °C; perdeu 5 kg. Exame: PA 112 × 70 mmHg, FC 104 bpm, abdome doloroso em hipogástrio, sem peritonite. Fundoscopia normal. Coproculturas, parasitológico com colorações especiais e pesquisa de toxinas de C. difficile negativos. PCR quantitativo para citomegalovírus no plasma: 6.800 cópias/mL. O próximo exame mais adequado é:

A) Colonoscopia com biópsias

B) TC de abdome com contraste

C) Antigenemia pp65 para CMV

D) Repetir PCR de CMV em 7 dias

---

18 Mulher de 41 anos, tabagista (20 maços-ano), tem doença de Graves diagnosticada há 4 meses e usa metimazol 20 mg/dia; está clinicamente eutireoidea, com T4 livre de 1,3 ng/dL (VR 0,9 a 1,8) e TRAb de 18 UI/L (VR até 1,75). Há 6 semanas tem dor retro-ocular espontânea e à movimentação dos olhos, hiperemia palpebral e conjuntival, edema palpebral e de carúncula (escore de atividade clínica de 5 em 7). Exoftalmometria: 24 mm à direita e 23 mm à esquerda (VR até 20 mm). Refere diplopia nos extremos do olhar para cima. Acuidade visual 20/20 bilateral, visão de cores normal, sem defeito pupilar aferente, fundo de olho sem edema de papila e córnea íntegra. A classificação da orbitopatia e a conduta mais adequada são, respectivamente:

A) Ativa e leve / selênio por 6 meses

B) Ameaçadora à visão / descompressão orbitária

C) Inativa / radioiodo com prednisona

D) Ativa, moderada a grave / metilprednisolona EV

---

19 Homem de 46 anos tem úlceras pépticas recorrentes há 3 anos. A última endoscopia mostrou duas úlceras, uma no bulbo e outra na segunda porção do duodeno, e pregas gástricas espessadas; biópsias negativas para H. pylori, confirmadas por sorologia negativa. Nega anti-inflamatórios, ácido acetilsalicílico e tabagismo. Tem diarreia aquosa crônica, que melhora nas fases em que o médico aumenta a dose do medicamento usado para a úlcera, que está em dose dobrada, em jejum e antes do jantar, há 8 meses. Cálcio sérico de 9,4 mg/dL. A gastrina sérica de jejum colhida na semana passada veio 480 pg/mL (referência até 100). O próximo exame mais adequado é:

A) Gastrina e pH gástrico sem o medicamento

B) Teste de estímulo com secretina sem suspensão

C) PET-CT com gálio-68 DOTATATE

D) Ecoendoscopia do pâncreas e do duodeno

---

20 Mulher de 63 anos, G4P4, está no 9º dia após artroplastia total do quadril direito. No pós-operatório imediato recebeu 2 concentrados de hemácias por sangramento do sítio cirúrgico, e usa enoxaparina 40 mg/dia desde o 1º dia, além de paracetamol. Hoje surgiram petéquias difusas, bolhas hemorrágicas na mucosa oral e epistaxe. Plaquetas: 245.000/mm³ no pré-operatório, 198.000/mm³ no 2º dia e 4.000/mm³ hoje, confirmadas em esfregaço sem agregados. Doppler venoso dos membros inferiores sem trombose. Hb 10,2 g/dL, estável; TP, TTPa e fibrinogênio normais; sem esquizócitos; LDH normal. Afebril, sem sinais de infecção. O diagnóstico mais provável é:

A) Púrpura trombocitopênica trombótica

B) Coagulação intravascular disseminada

C) Trombocitopenia induzida por heparina

D) Púrpura pós-transfusional

---

21 Mulher de 71 anos, tabagista, com hipertensão há 20 anos, usa anlodipino 10 mg, losartana 100 mg, clortalidona 25 mg e espironolactona 25 mg, com PA de consultório de 138/84 mmHg. Nos últimos 6 meses teve dois episódios de edema agudo de pulmão de instalação súbita, com PA de 220/120 mmHg na chegada, resolvidos com nitrato e diurético. Ecocardiograma: fração de ejeção de 62%, sem valvopatia significativa; cateterismo sem lesões coronarianas obstrutivas. Creatinina 1,4 mg/dL, estável há 1 ano; potássio 4,6 mEq/L. Angiotomografia: estenose aterosclerótica de 80% no óstio da artéria renal direita, rim direito de 9,8 cm e esquerdo de 11 cm, sem lesão à esquerda. A conduta mais adequada é:

A) Angioplastia renal com stent

B) Manter o tratamento clínico otimizado

C) Suspender a losartana

D) Nefrectomia direita

---

22 Homem de 67 anos, com diabetes tipo 2 há 22 anos, doença renal crônica (TFG 34 mL/min/1,73 m²) e tabagismo ativo, tem dor em panturrilha esquerda ao caminhar dois quarteirões, que cede com 3 minutos de repouso, há 8 meses. Nega dor em repouso. Exame: pele fina e sem pelos no terço distal da perna esquerda, pulsos poplíteo, tibial posterior e pedioso esquerdos não palpáveis, sem úlceras; sensibilidade ao monofilamento reduzida nos dois pés. Índice tornozelo-braquial de 1,48 à esquerda e 1,32 à direita. Para confirmar o diagnóstico, o próximo exame é:

A) Índice hálux-braquial

B) Arteriografia dos membros inferiores

C) Índice tornozelo-braquial pós-esforço

D) Eletroneuromiografia dos membros inferiores

---

23 Homem de 63 anos, em quimioterapia paliativa com gencitabina por adenocarcinoma de pâncreas com metástases hepáticas, faz TC de reestadiamento que mostra, de forma incidental, falha de enchimento em uma única artéria subsegmentar do lobo inferior direito. Nega dispneia, dor torácica e hemoptise. PA 124 × 76 mmHg, FC 82 bpm, SpO2 97%. Ultrassonografia venosa compressiva dos membros inferiores: sem trombose. Hemoglobina 11,2 g/dL, plaquetas 210.000/mm³, creatinina 0,9 mg/dL; sem sangramento recente. O radiologista comenta no laudo que falhas subsegmentares isoladas costumam ser artefato e muitas vezes dispensam tratamento. A conduta mais adequada é:

A) Vigilância com ultrassonografia seriada

B) Anticoagulação plena por 6 meses

C) Filtro de veia cava inferior isolado

D) Enoxaparina em dose profilática

---

24 Mulher de 66 anos tem artrite reumatoide há 2 anos, com anti-CCP de 280 U/mL, erosões nas radiografias de mãos e DAS28 de 5,4, apesar de metotrexato 25 mg/semana subcutâneo com ácido fólico há 6 meses. Tabagista de 30 maços-ano, teve infarto do miocárdio há 3 anos, tratado com angioplastia. Não tem doença pulmonar intersticial, insuficiência cardíaca, neoplasia ou história de tuberculose; IGRA negativo. Prefere tratamento por via oral. A conduta mais adequada é associar ao metotrexato:

A) Tofacitinibe 5 mg duas vezes ao dia

B) Um anti-TNF por via subcutânea

C) Prednisona 10 mg/dia contínua

D) Sulfassalazina e hidroxicloroquina

---

25 Mulher de 79 anos, hipertensa controlada com losartana, relata três episódios nas últimas 2 semanas, cada um com cerca de 15 minutos, de formigamento que começa nos dedos da mão esquerda e 'sobe' em 1 a 2 minutos até o ombro e o lado esquerdo da boca, com resolução completa. Nega perda de força, alteração da fala ou da visão. Tem queixa de esquecimento há 2 anos (MEEM 24). Ritmo cardíaco regular, sem sopros carotídeos, PA 136/80 mmHg, glicemia 104 mg/dL. Exame neurológico atual normal. TC de crânio sem contraste sem lesões agudas. ECG em ritmo sinusal. A equipe pretende iniciar AAS e clopidogrel após o próximo exame. O exame mais adequado neste momento é:

A) Doppler de artérias carótidas e vertebrais

B) RM com sequência de suscetibilidade

C) Eletroencefalograma

D) Holter de 24 horas

---

26 Mulher de 64 anos, menopausada aos 51, foi submetida a setorectomia com biópsia de linfonodo sentinela por carcinoma ductal invasivo de 1,6 cm, grau 2, receptores de estrogênio e progesterona positivos, HER2 negativo, linfonodo sentinela negativo; fará radioterapia. O risco genômico de recorrência foi baixo e a quimioterapia foi dispensada. Antecedentes: hipertensão em uso de losartana; há 3 anos, após artroplastia total do joelho esquerdo, teve dor e edema da panturrilha esquerda e usou rivaroxabana por 3 meses. Não fuma. Nunca fez densitometria óssea. A hormonioterapia adjuvante mais adequada e o exame a solicitar junto são:

A) Tamoxifeno com ultrassonografia transvaginal anual

B) Anastrozol, com densitometria óssea basal

C) Raloxifeno, com densitometria óssea basal

D) Tamoxifeno por 5 anos, sem exame adicional

---

27 Homem de 26 anos, garimpeiro em Roraima, tem febre em dias alternados há 5 dias. Gota espessa: Plasmodium vivax, 2.000 parasitos/mm³. Sem sinais de gravidade: lúcido, sem icterícia, Hb 12,8 g/dL, plaquetas 92.000/mm³, creatinina 0,9 mg/dL, aceitando a via oral. Peso 70 kg. O teste quantitativo de atividade da G6PD, feito no posto conforme o protocolo, mostrou atividade de 28% do normal. Nunca teve malária. O serviço dispõe de cloroquina, primaquina e tafenoquina. Além da cloroquina por 3 dias, para a cura radical o mais adequado é:

A) Tafenoquina em dose única

B) Primaquina diária por 7 dias

C) Omitir a cura radical

D) Primaquina semanal por 8 semanas

---

28 Homem de 72 anos, com síndrome mielodisplásica de baixo risco pelo IPSS-R, é dependente de transfusão há 2 anos e já recebeu cerca de 40 concentrados de hemácias, após falha da alfaepoetina. Está ativo, com ECOG 1. Ferritina 3.100 ng/mL, saturação de transferrina 88%, ressonância com T2* hepático indicando 9 mg de ferro por grama de fígado seco; T2* cardíaco normal. Tem doença renal crônica por nefroesclerose, com TFGe estável de 34 mL/min/1,73 m², e neutrófilos de 800/mm³ pela própria SMD. Plaquetas 96.000/mm³. A conduta mais adequada para a sobrecarga de ferro é:

A) Deferasirox oral

B) Deferiprona oral

C) Flebotomias mensais

D) Desferroxamina subcutânea

---

29 Homem de 44 anos vive com HIV há 10 anos. Há 8 meses, por falha virológica, passou a usar tenofovir, lamivudina e darunavir potencializado com ritonavir; a carga viral está indetectável e o CD4 é de 520 células/mm³. Tem asma persistente e, há 6 meses, o pneumologista aumentou a fluticasona inalatória para 500 mcg duas vezes ao dia. Desde então ganhou 9 kg, concentrados na face e no tronco, com giba dorsal, estrias violáceas largas no abdome, equimoses aos mínimos traumas e dificuldade para subir escadas. PA 152 × 96 mmHg, glicemia de jejum 168 mg/dL. Exames às 8 horas: cortisol sérico 1,1 mcg/dL (VR 5 a 25) e ACTH 4 pg/mL (VR 10 a 60). O diagnóstico mais provável é:

A) Insuficiência adrenal secundária isolada

B) Doença de Cushing por adenoma hipofisário

C) Síndrome de Cushing exógena por interação

D) Lipodistrofia associada à terapia antirretroviral

---

30 Homem de 67 anos, com diabetes tipo 2 há 20 anos, está internado há 12 dias por osteomielite do pé com bacteremia por Staphylococcus aureus sensível à oxacilina, em uso de oxacilina; as hemoculturas do quinto dia ainda eram positivas e a úlcera continua drenando secreção purulenta. Creatinina basal 1,1 mg/dL, hoje 3,2 mg/dL. EAS: 50 hemácias por campo, 70% dismórficas, cilindros hemáticos, proteinúria 2+; proteinúria de 2,4 g/24 h. Sem exantema, sem eosinofilia, sem púrpura. C3 levemente reduzido, C4 normal, ANCA negativo. Ecocardiograma transesofágico sem vegetações. A biópsia renal mostra glomerulonefrite proliferativa endocapilar e exsudativa com depósitos dominantes de IgA e de C3 na imunofluorescência. A causa mais provável da lesão renal é:

A) Glomerulonefrite associada ao estafilococo

B) Nefropatia por IgA primária

C) Nefrite intersticial pela oxacilina

D) Vasculite por IgA do adulto

---

31 Homem de 38 anos iniciou carbamazepina há 5 semanas para neuralgia do trigêmeo. Há 6 dias tem febre de 39 °C, exantema morbiliforme confluente em mais de 60% da superfície corporal, edema facial e linfonodomegalias cervicais e axilares. Sem bolhas e sem erosões de mucosas. Exames: leucócitos 16.800/mm³ com 2.300 eosinófilos/mm³ e linfócitos atípicos, ALT 620 U/L, AST 410 U/L, bilirrubina total 1,4 mg/dL, INR 1,1, creatinina 0,9 mg/dL, EAS normal. A carbamazepina foi suspensa no primeiro dia, e a dor facial voltou a ser intensa. O tratamento da reação e o fármaco para a dor facial são, respectivamente:

A) Prednisona 1 mg/kg / oxcarbazepina

B) Suspensão e suporte apenas / oxcarbazepina

C) Prednisona 1 mg/kg / gabapentina

D) Suspensão e suporte apenas / gabapentina

---

32 Mulher de 44 anos, tabagista de 20 maços-ano, com enxaqueca sem aura em profilaxia com propranolol 80 mg/dia há 6 meses e crises tratadas com sumatriptano, procura o ambulatório por episódios de opressão retroesternal que a despertam entre 4 h e 6 h, duram cerca de 10 minutos e cedem espontaneamente, três a quatro vezes por semana, há 4 meses. Caminha 5 km por dia sem sintomas. O Holter flagrou, durante um episódio às 5 h, supradesnivelamento de ST de 3 mm em DII, DIII e aVF, desfeito em 8 minutos. Angiotomografia de coronárias sem placas, escore de cálcio zero. PA 118×72 mmHg, FC 58 bpm; troponina e ecocardiograma normais. Além de cessar o tabagismo, a conduta antianginosa e a conduta com os remédios da enxaqueca são, respectivamente:

A) Bloqueador de cálcio e nitrato / manter propranolol e triptano

B) Bloqueador de cálcio e nitrato / suspender propranolol e triptano

C) AAS e estatina / manter propranolol e triptano

D) AAS e estatina / suspender propranolol e triptano

---

33 Homem de 19 anos, recruta militar, previamente hígido, começou a fumar cigarros há três semanas. Há 4 dias tem febre de 38,5 °C, tosse seca, mialgia e dispneia progressiva; dois colegas de alojamento tiveram pneumonia no último mês. Internado como pneumonia comunitária grave, recebe ceftriaxona e azitromicina há 72 horas, sem melhora. Hoje: FR 32 irpm, SpO2 86% com máscara de reservatório, PA 118 × 72 mmHg. Leucócitos 14.800/mm³ com 2% de eosinófilos; procalcitonina 0,2 ng/mL. TC: vidro fosco difuso, espessamento de septos interlobulares e pequeno derrame pleural bilateral, sem nódulos centrolobulares e sem consolidação. Ecocardiograma com função ventricular normal. Antígenos urinários e PCR para vírus respiratórios negativos. Nega contato com aves, mofo ou vapores. O diagnóstico mais provável é:

A) Pneumonia eosinofílica aguda

B) Pneumonia por Mycoplasma pneumoniae

C) Pneumonite de hipersensibilidade aguda

D) Pneumonia intersticial aguda

---

34 Mulher de 54 anos, sem consumo de álcool, procura atendimento por fadiga e icterícia leve há 6 semanas. Exames: ALT 640 U/L, AST 590 U/L, bilirrubina total 3,2 mg/dL, fosfatase alcalina 160 U/L, IgG 3.400 mg/dL (2,1 vezes o limite superior), FAN 1:320 padrão homogêneo, antimúsculo liso 1:160, sorologias virais negativas, ceruloplasmina normal. A biópsia hepática mostra hepatite de interface com infiltrado linfoplasmocitário e rosetas. A elastografia hepática transitória mede 16 kPa, a ultrassonografia mostra fígado de contornos irregulares e esplenomegalia, e a endoscopia, varizes esofágicas de fino calibre. Albumina 3,4 g/dL, INR 1,2, sem ascite nem encefalopatia. Quanto ao corticoide de indução e ao exame a obter antes da azatioprina, respectivamente:

A) Budesonida / atividade da TPMT

B) Prednisona / atividade da TPMT

C) Budesonida / atividade da G6PD

D) Prednisona / atividade da G6PD

---

35 Um homem com ferimento por arma branca no dorso tem, abaixo da lesão, fraqueza e perda da propriocepção na perna direita e perda da sensibilidade dolorosa e térmica à esquerda a partir da cicatriz umbilical (T10). O lado da medula e o segmento lesados são, respectivamente:

A) Esquerdo / T10

B) Direito / T10

C) Esquerdo / T8

D) Direito / T8

---

36 Mulher de 27 anos, com epistaxes recorrentes e menorragia desde a menarca e sangramento prolongado após extração dentária; a mãe tem a mesma história. Escore de sangramento da ISTH de 9. Plaquetas de 92.000/mm³, sempre entre 80.000 e 110.000/mm³ em exames anteriores, sem agregados em amostra com citrato. TP normal, TTPa levemente prolongado. Fator de von Willebrand antigênico 38%, atividade (ligação à GPIb) 14%, fator VIII 40%. Agregação plaquetária induzida por ristocetina aumentada em baixa concentração, e multímeros com perda dos de alto peso molecular. Está programada a extração dos quatro terceiros molares. Para a profilaxia hemostática do procedimento, a medida mais adequada é:

A) Ácido tranexâmico isolado

B) Concentrado de fator VIII com fator de von Willebrand

C) Desmopressina subcutânea

D) Transfusão de plaquetas pré-procedimento

---

37 Homem de 52 anos, lavrador no interior de Minas Gerais, foi picado no pé esquerdo há 6 horas por serpente que fugiu. Refere pouca dor local; o pé tem apenas parestesia e discreto edema, sem equimose ou bolhas. Queixa visão turva e dor muscular generalizada intensa. Exame: ptose palpebral bilateral evidente, oftalmoplegia, força preservada nos membros, FR 18 irpm, SpO2 97%. Urina avermelhada escura e diurese de 15 mL/h nas últimas 3 horas. Tempo de coagulação: 25 minutos (referência: até 10 minutos). CK 9.800 U/L, creatinina 2,1 mg/dL. O tipo de acidente e a sua classificação de gravidade são, respectivamente:

A) Crotálico / moderado

B) Elapídico / grave

C) Crotálico / grave

D) Botrópico / grave

---

38 Homem de 26 anos, descendente de japoneses, acorda sem conseguir levantar da cama, com fraqueza nas quatro extremidades, após jantar com grande quantidade de massas e cerveja na véspera. Teve episódio semelhante e mais leve há 2 meses, com recuperação espontânea em horas. Refere perda de 5 kg em 3 meses e palpitações. Não usa diuréticos nem laxantes; sem vômitos ou diarreia. Exame: PA 142/68 mmHg, FC 124 bpm, tremor fino, tireoide difusamente aumentada, força grau 2 proximal nos quatro membros, reflexos abolidos, sensibilidade normal. Exames: potássio 1,9 mEq/L, bicarbonato 24 mEq/L, magnésio 2,0 mg/dL, fósforo 2,0 mg/dL, potássio urinário em amostra isolada de 9 mEq/L. ECG com ondas U proeminentes. Quanto à reposição de potássio e ao betabloqueador, a conduta é, respectivamente:

A) Agressiva / apenas metimazol

B) Cautelosa / apenas metimazol

C) Agressiva / propranolol oral

D) Cautelosa / propranolol oral

---

39 Mulher de 29 anos, assintomática, usa DIU de cobre e não planeja engravidar. Em exame admissional: glicemia de jejum de 128 mg/dL, repetida em 131 mg/dL, e HbA1c de 6,4%. IMC 22 kg/m², PA 114 × 72 mmHg, sem acantose. Lembra que tinha "glicose um pouco alta" já aos 16 anos. O pai, de 58 anos, tem glicemia de jejum entre 120 e 135 mg/dL há 30 anos, nunca tratou e não tem retinopatia nem nefropatia; o sequenciamento genético dele identificou variante patogênica no gene da glicoquinase. Exames dela: anti-GAD negativo, peptídeo C 1,9 ng/mL, triglicerídeos 82 mg/dL, HDL 64 mg/dL, relação albumina/creatinina urinária normal. Teste oral com 75 g: jejum 129 mg/dL e 2 horas 168 mg/dL. A conduta mais adequada é:

A) Sem tratamento farmacológico

B) Metformina 1.000 mg/dia

C) Gliclazida em dose baixa

D) Insulina basal em dose baixa

---

40 Homem de 61 anos, diabético, em hemodiálise por fístula arteriovenosa, tem bacteremia por Staphylococcus aureus sensível à oxacilina, com duas hemoculturas positivas, a partir de flebite em acesso periférico já retirado. Ecocardiograma transesofágico sem vegetações; hemoculturas de controle negativas em 48 horas. Relata alergia a penicilina: aos 20 anos, no 5º dia de amoxicilina, teve exantema maculopapular pruriginoso sem acometimento de mucosas, sem bolhas, sem dispneia e sem hipotensão, que regrediu em 4 dias. Desde então nunca recebeu betalactâmico. Iniciou-se vancomicina empírica. O antimicrobiano mais adequado para completar o tratamento é:

A) Daptomicina

B) Cefazolina

C) Vancomicina

D) Linezolida

---

41 Homem de 74 anos, em hemodiálise por nefropatia diabética, com fibrilação atrial anticoagulada com apixabana, apresentou hipotensão intradialítica (PA 78 × 44 mmHg) seguida, horas depois, de dor em fossa ilíaca direita e duas evacuações com sangue vivo misturado às fezes. Exame: Tax 37,4 °C, FC 92 bpm irregular, PA 132 × 78 mmHg, abdome com dor leve à palpação profunda do flanco direito, sem peritonite. Hb 11,2 g/dL (basal 11,6), lactato 1,6 mmol/L. A colonoscopia, no dia seguinte, mostrou edema, hemorragia submucosa e úlceras rasas no ceco e no cólon ascendente, com reto e cólon esquerdo sem alterações; as biópsias são compatíveis com isquemia. O paciente evolui estável. O próximo exame mais adequado é:

A) Pesquisa de trombofilia hereditária

B) Ecocardiograma transesofágico

C) Angiotomografia das artérias mesentéricas

D) Colonoscopia de controle em 2 semanas

---

42 Homem de 21 anos é encaminhado pelo urologista que operou criptorquidia bilateral na infância e agora investiga infertilidade. Mede 1,58 m e tem pescoço curto e alado, implantação baixa dos cabelos na nuca, hipertelorismo, ptose palpebral bilateral, orelhas de implantação baixa e pectus excavatum superior com pectus carinatum inferior. Cariótipo de sangue periférico 46,XY. Desenvolvimento escolar normal. Nega sintomas cardiovasculares. Exame: PA 118×74 mmHg no braço direito e 128×76 mmHg na coxa, pulsos femorais amplos e sem retardo, ictus não desviado, impulsão sistólica na borda esternal esquerda baixa. ECG: desvio do eixo para a direita e onda R ampla em V1. O conjunto auscultatório esperado é:

A) Sopro holossistólico em borda esternal baixa

B) Desdobramento fixo de B2 e ruflar tricúspide

C) Sopro ejetivo pulmonar com P2 hipofonética

D) Clique ejetivo aórtico e sopro interescapular

---

43 Um hospital divulga que, entre os casos de câncer de pulmão detectados pelo seu programa de rastreamento com TC de baixa dose, a sobrevida em 5 anos contada a partir do diagnóstico foi de 62%, contra 18% entre os casos diagnosticados por sintomas no mesmo período. Os casos rastreados tinham mais tumores em estádio I e foram operados com mais frequência. Não houve randomização, e ninguém comparou a população rastreada com uma população semelhante não rastreada. Para concluir que o rastreamento traz benefício real, o desfecho a comparar entre um grupo rastreado e outro não rastreado é:

A) Sobrevida em 5 anos após o diagnóstico

B) Proporção de tumores em estádio I

C) Taxa de ressecção cirúrgica curativa

D) Mortalidade por câncer de pulmão

---

44 Homem de 31 anos, que faz sexo com homens, vive com HIV com carga viral indetectável e usa preservativo de forma irregular, procura atendimento por dor anal, tenesmo, secreção mucopurulenta com sangue e constipação há 10 dias. Exame: T 37,8 °C; linfonodos inguinais pequenos e indolores; sem úlcera perianal visível. Anuscopia: mucosa retal friável, com exsudato e ulcerações rasas. Teste molecular (NAAT) do swab retal: Chlamydia trachomatis detectada e Neisseria gonorrhoeae não detectada. VDRL não reagente. O laboratório não dispõe de genotipagem para os sorovares L1 a L3. O tratamento mais adequado é:

A) Azitromicina 1 g em dose única

B) Doxiciclina 100 mg 12/12 h por 7 dias

C) Doxiciclina 100 mg 12/12 h por 21 dias

D) Ceftriaxona IM e doxiciclina por 7 dias

---

45 Homem de 58 anos, hipertenso controlado, tem há 6 semanas fadiga, equimoses e gengivorragia. Sem esplenomegalia, linfonodomegalias ou hepatomegalia. Hb 7,2 g/dL, VCM 102 fL, reticulócitos 12.000/mm³, leucócitos 1.400/mm³ (neutrófilos 340/mm³), plaquetas 9.000/mm³. B12 e folato normais; anti-HIV, sorologias para hepatites e para parvovírus B19 negativas. Biópsia de medula: celularidade de 10%, sem fibrose, sem blastos, sem infiltração e sem displasia significativa; cariótipo normal. Citometria de fluxo com clone HPN de 2% nos granulócitos. Tem um irmão de 54 anos, saudável, HLA-idêntico. A classificação de gravidade e o tratamento de primeira linha são, respectivamente:

A) Grave / ATG, ciclosporina e eltrombopague

B) Grave / transplante alogênico aparentado

C) Muito grave / transplante alogênico aparentado

D) Muito grave / ATG, ciclosporina e eltrombopague

---

46 Mulher de 33 anos, no 18º dia pós-parto vaginal sem intercorrências, procura o pronto-socorro pela quarta cefaleia explosiva em 8 dias, holocraniana, que atinge o máximo em menos de 1 minuto, desencadeada por esforço evacuatório e banho; entre as crises sente dor leve. Iniciou sertralina 50 mg/dia há 2 semanas por depressão puerperal e usa oximetazolina nasal várias vezes ao dia por rinite. PA 148/92 mmHg, sem proteinúria, plaquetas e enzimas hepáticas normais. Exame neurológico normal. TC de crânio normal; punção lombar sem xantocromia, 2 células/mm³ e proteína de 32 mg/dL. Angiotomografia: estreitamentos segmentares multifocais em ramos das artérias cerebrais médias e anteriores, sem aneurisma, com laudo de 'aspecto sugestivo de vasculite'; seios venosos pérvios. A conduta mais adequada é:

A) Pulsoterapia com metilprednisolona

B) Anticoagulação plena com enoxaparina

C) Retirar sertralina e oximetazolina

D) Biópsia leptomeníngea e cortical

---

47 Homem de 31 anos, vivendo com HIV há 6 anos, em uso de tenofovir, lamivudina e dolutegravir, com último CD4 de 680 células/mm³ e carga viral indetectável há 4 anos, procura atendimento por dor retroesternal intensa ao engolir há 3 dias, que começou de forma súbita. Desde o mês passado usa doxiciclina 200 mg como profilaxia pós-exposição a IST, que tomou nas últimas quatro noites seguidas, deitando-se logo após, com pouco líquido. Nega febre, perda de peso e lesões orais; orofaringe sem placas. A endoscopia mostra úlcera única, rasa, de 1,2 cm, com bordas bem definidas, no terço médio do esôfago, na altura da compressão do arco aórtico, com mucosa ao redor normal; esôfago distal sem lesões. A etiologia mais provável é:

A) Esofagite por citomegalovírus

B) Esofagite herpética

C) Úlcera aftosa idiopática do HIV

D) Esofagite induzida por comprimido

---

48 Mulher de 52 anos é submetida a colecistectomia eletiva. Cinco minutos após a indução com propofol, fentanil, rocurônio e cefazolina profilática, apresenta PA de 60 × 30 mmHg, FC 138 bpm, broncoespasmo com aumento da pressão de pico e eritema difuso no tronco. Recebe adrenalina intravenosa em bolus titulados e cristaloide, com estabilização em 15 minutos, e a cirurgia é adiada. Agora, 40 minutos após o início do quadro, está estável e extubada. Nunca foi operada e não tem alergias conhecidas. O exame mais adequado neste momento é:

A) Triptase sérica agora e após 24 horas

B) Histamina plasmática após 24 horas

C) IgE específica para látex e cefazolina

D) Testes cutâneos com os fármacos usados

---

49 Mulher de 38 anos, com 50 kg e previamente hígida, iniciou aciclovir intravenoso 10 mg/kg a cada 8 horas, infundido em 20 minutos, por suspeita de encefalite herpética. Por estar em jejum, recebeu apenas 500 mL de cristaloide nas primeiras 24 horas. Creatinina de admissão 0,7 mg/dL; 40 horas depois, 2,4 mg/dL, com dor lombar bilateral e diurese de 0,6 mL/kg/h. PA 122/76 mmHg, afebril, sem exantema. EAS com leucocitúria discreta, hematúria microscópica e sem eosinófilos na urina; ultrassom com rins de tamanho normal, sem hidronefrose. Não recebeu contraste, anti-inflamatório nem aminoglicosídeo. O mecanismo mais provável da lesão renal é:

A) Vasoconstrição da arteríola aferente

B) Precipitação de cristais nos túbulos

C) Necrose tubular por hipoperfusão

D) Nefrite intersticial de hipersensibilidade

---

50 Mulher de 39 anos foi submetida a bypass gástrico em Y de Roux há 3 anos e perdeu 48 kg. Há 5 meses tem episódios de tremor, sudorese, confusão e, uma vez, síncope, que ocorrem 1 a 3 horas após refeições ricas em doces e massas. Em um episódio, a glicemia capilar foi de 44 mg/dL, com melhora após ingerir suco. Também tem palpitações e diarreia nos primeiros 30 minutos após comer. Nunca teve sintomas em jejum, inclusive no jejum de 14 horas que fez para exames. Usa apenas polivitamínico e não tem diabetes. Exame físico normal, IMC 26 kg/m². Para confirmar a principal hipótese diagnóstica, o exame mais adequado é:

A) Teste oral de tolerância com 75 g

B) Teste de refeição mista padronizada

C) Tomografia de pâncreas com contraste

D) Jejum supervisionado de 72 horas

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado 7

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1 (A) (B) (C) (D)	2 (A) (B) (C) (D)	3 (A) (B) (C) (D)	4 (A) (B) (C) (D)
5 (A) (B) (C) (D)	6 (A) (B) (C) (D)	7 (A) (B) (C) (D)	8 (A) (B) (C) (D)
9 (A) (B) (C) (D)	10 (A) (B) (C) (D)	11 (A) (B) (C) (D)	12 (A) (B) (C) (D)
13 (A) (B) (C) (D)	14 (A) (B) (C) (D)	15 (A) (B) (C) (D)	16 (A) (B) (C) (D)
17 (A) (B) (C) (D)	18 (A) (B) (C) (D)	19 (A) (B) (C) (D)	20 (A) (B) (C) (D)
21 (A) (B) (C) (D)	22 (A) (B) (C) (D)	23 (A) (B) (C) (D)	24 (A) (B) (C) (D)
25 (A) (B) (C) (D)	26 (A) (B) (C) (D)	27 (A) (B) (C) (D)	28 (A) (B) (C) (D)
29 (A) (B) (C) (D)	30 (A) (B) (C) (D)	31 (A) (B) (C) (D)	32 (A) (B) (C) (D)
33 (A) (B) (C) (D)	34 (A) (B) (C) (D)	35 (A) (B) (C) (D)	36 (A) (B) (C) (D)
37 (A) (B) (C) (D)	38 (A) (B) (C) (D)	39 (A) (B) (C) (D)	40 (A) (B) (C) (D)
41 (A) (B) (C) (D)	42 (A) (B) (C) (D)	43 (A) (B) (C) (D)	44 (A) (B) (C) (D)
45 (A) (B) (C) (D)	46 (A) (B) (C) (D)	47 (A) (B) (C) (D)	48 (A) (B) (C) (D)
49 (A) (B) (C) (D)	50 (A) (B) (C) (D)		